

医药生物周报（25 年第 25 周）

2025 ADA 大会数据总结，关注潜在出海机会

优于大市

核心观点

本周医药板块表现弱于整体市场，医药各个板块均下跌。本周全部 A 股下跌 0.67%（总市值加权平均），沪深 300 下跌 0.45%，中小板指下跌 0.43%，创业板指下跌 1.66%，生物医药板块整体下跌 4.35%，生物医药板块表现弱于整体市场。分子板块来看，化学制药下跌 5.48%，生物制品下跌 3.94%，医疗服务下跌 4.92%，医疗器械下跌 3.24%，医药商业下跌 4.42%，中药下跌 2.93%。医药板块当前市盈率(TTM)为 33.39x，处于近 5 年历史估值的 66.69%分位数。

2025 ADA 大会数据总结，关注潜在出海机会。2025 年 6 月 20 日-23 日，第 85 届美国糖尿病协会科学会议（ADA）于美国芝加哥召开，包括礼来、诺和诺德等海外大型制药企业及众多中国创新药企业出席并展示了最新的研究成果。

礼来公布其增肌减脂在研管线 Bimagrumb 联用 Semaglutide 减重数据。治疗第 72 周，Bimagrumb 联用 Semaglutide 组平均体重较基线 -22.1% vs -10.8% Bima vs -15.7% Sema；代谢相关的次要终点方面，联合治疗组减去了更多的内脏脂肪，炎症 biomarker 如 hsCRP 显著降低，甘油三酯、血压降低幅度更大。常见副作用包括肌肉痉挛、腹泻、痤疮等，ALT 和脂肪酶早期表现出暂时性的升高。

安进公布了其 4 周一次给药 MariTide 减重 Ph2 临床研究完整数据，高剂量组 52 周实现~20%减重，但 420 mg 剂量递增及固定剂量组分别出现了~11%及 22%~29%副作用导致的停药率；从 Ph1 PK 数据来看，多阶梯的剂量递增方案能够大幅改善胃肠道相关的副作用，Amgen 在 MariTide 减重 Ph3 临床研究中将采用 21 mg-35 mg-70 mg-目标剂量的 3 阶剂量爬坡模式，有望进一步改善其安全性。

建议关注：国内减重药物在长效化、口服、多靶点联用及减脂不减肌等方面具备差异化优势，关注潜在出海机会。

风险提示：研发失败风险；商业化不及预期风险；地缘政治风险；政策超预期风险。

重点公司盈利预测及投资评级

公司 代码	公司 名称	投资 评级	总市值 (亿元)	归母净利润(亿元)				PE			
				2024A	2025E	2026E	2027E	2024A	2025E	2026E	2027E
300760.SZ	迈瑞医疗	优于大市	2755	116.7	124.1	141.0	161.9	23.6	22.2	19.5	17.0
603259.SH	药明康德	优于大市	1893	93.5	111.6	127.3	145.1	20.2	17.0	14.9	13.1
300832.SZ	新产业	优于大市	456	18.3	20.4	24.3	28.8	24.9	22.4	18.8	15.8
688617.SH	惠泰医疗	优于大市	387	6.7	8.8	11.3	14.7	57.5	44.2	34.1	26.3
300633.SZ	开立医疗	优于大市	129	1.4	3.1	4.0	4.8	90.8	41.3	32.6	26.8
688212.SH	澳华内镜	优于大市	62	0.2	0.5	1.0	1.2	295.1	114.8	63.3	50.0
300685.SZ	艾德生物	优于大市	82	2.5	3.2	3.8	4.5	32.1	25.8	21.4	18.2
688050.SH	爱博医疗	优于大市	131	3.9	4.7	5.8	7.2	33.7	27.9	22.6	18.2
603882.SH	金城医学	优于大市	125	(3.8)	6.9	8.5	-	(32.7)	18.1	14.8	-
9926.HK	康方生物	优于大市	748	(5.1)	0.3	7.3	17.9	(145.5)	2581.0	102.5	41.7
6990.HK	科伦博泰生物-B	优于大市	686	(2.7)	(7.2)	(3.0)	4.8	(257.2)	(95.2)	(227.2)	144.5
0013.HK	和黄医药	优于大市	188	2.7	24.9	8.5	11.8	69.4	7.6	22.1	16.0
2162.HK	康诺亚-B	优于大市	122	(5.2)	(8.0)	(5.8)	0.5	(23.6)	(15.2)	(20.9)	253.5
1530.HK	三生制药	优于大市	456	20.9	23.9	27.1	30.7	21.8	19.1	16.8	14.9
1789.HK	爱康医疗	优于大市	61	2.7	3.3	4.0	4.8	22.2	18.2	15.1	12.6

资料来源：Wind、国信证券经济研究所预测

行业研究 · 行业周报

医药生物

优于大市 · 维持

证券分析师：陈曦炳

0755-81982939

chenxibing@guosen.com.cn

S0980521120001

证券分析师：彭思宇

0755-81982723

cnpengsiyu@guosen.com.cn

S0980521060003

证券分析师：马千里

010-88005445

maqianli@guosen.com.cn

S0980521070001

市场走势



资料来源：Wind、国信证券经济研究所整理

相关研究报告

《医药生物周报（25 年第 24 周）-政策出台加速+AI 应用落地有望带来医疗服务行业新增长》——2025-06-22

《创新药盘点系列报告（22）：IBD 治疗领域存在未满足的需求，关注新靶点、新机制》——2025-06-17

《临床与对外合作均取得实质进展，持续关注创新药——医药生物行业 2025 年 6 月投资策略》——2025-06-15

《医药生物周报（25 年第 23 周）-炎症性肠病数据梳理，关注具备创新资产的标的》——2025-06-15

《医药生物周报（25 年第 22 周）-血液净化器械行业分析，关注产业链国产替代趋势》——2025-06-04

内容目录

2025 ADA 大会数据总结	4
Amylin	4
口服小分子 GLP-1	7
减脂不减肌	9
超长效	9
新股上市跟踪	12
本周行情回顾	13
板块估值情况	15
推荐标的	16
风险提示	18

图表目录

图 1: Amycretin 1.25~60 mg 剂量组 20~36 周减重数据	4
图 2: Eloralintide 12 周减重数据	5
图 3: Petrelintide 16 周减重数据	6
图 4: 第 40 周 HbA1c 较基线变化	7
图 5: 第 40 周平均体重较基线变化	7
图 6: MariTide Ph2 临床肥胖/超重 +/- T2D 患者 52 周减重数据	10
图 7: T2D 患者中 GZR18 对照 Semaglutide 治疗 24 周数据	11
图 8: 申万一级行业一周涨跌幅 (%)	13
图 9: 申万一级行业市盈率情况 (TTM)	15
图 10: 医药行业子板块一周涨跌幅 (%)	15
图 11: 医药行业子板块市盈率情况 (TTM)	15
表 1: 近期 A 股/H 股医药板块新股上市情况跟踪	12
表 2: 本周 A 股涨跌幅前十的个股情况	14

2025 ADA 大会数据总结

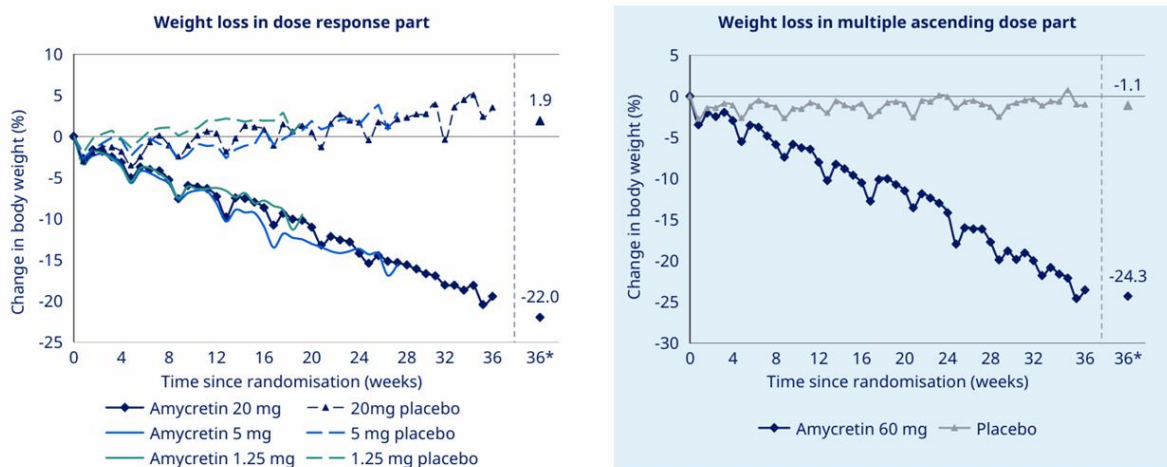
Amylin

■ Novo Nordisk: Amycretin 60mg 剂量 36 周减重 24.3%

Ph1b/2a: 纳入成人受试者, BMI 介于 27.0~39.9 kg/m², 且 HbA1c<6.5%。受试者随机分为 SC Amycretin 组 (N=101) 或安慰剂组 (N=24)。研究共分为五部分: A 部分 (SAD): 单次给药, 共设 3 个剂量组 (0.3 mg、0.6 mg、1 mg); B 部分 (MAD): 每周一次 (OW) 皮下注射, 剂量每 4 周递增, 从 0.3 mg 增至 60mg, 持续 36 周; C、D、E 三部分 (MAD): 每周一次皮下注射, 剂量每 4 周递增, 至维持剂量, 分别为 20 mg、5 mg 或 1.25 mg, 且在维持剂量下继续治疗 12 周, 总疗程分别为: C 部分 36 周、D 部分 28 周、E 部分 20 周。主要终点为治疗出现的不良事件 (TEAE) 数量。次要终点包括药物暴露量 (AUC)、最大血药浓度 (Cmax) 及 B-E 部分体重相对基线的变化百分比。

有效性: B-E 部分研究对象入组时平均 BMI 为 30.0~33.1 kg/m²; 第 20 周, Amycretin 1.25 mg SC QW 组体重较基线-9.7% vs +2.0% pbo, 28 周 5 mg QW 组-16.2% vs +2.3% pbo, 36 周 20/60 mg 组分别-22.0% vs +1.9% pbo 及-24.3% vs -1.1% pbo。

图1: Amycretin 1.25~60 mg 剂量组 20~36 周减重数据



资料来源: ADA 2025, 国信证券经济研究所整理

安全性: 目前的剂量递增方案表明, Amycretin 在最高达 60 mg 时仍具有良好安全性和耐受性 (与 GLP-1 及 Amylin 激动剂相当); 发生最频繁的 TEAE 为胃肠道不良反应, 如恶心、呕吐及腹泻, 大多为轻度至中度。随着剂量增加, AUC 和 Cmax 呈与剂量成比例增加。

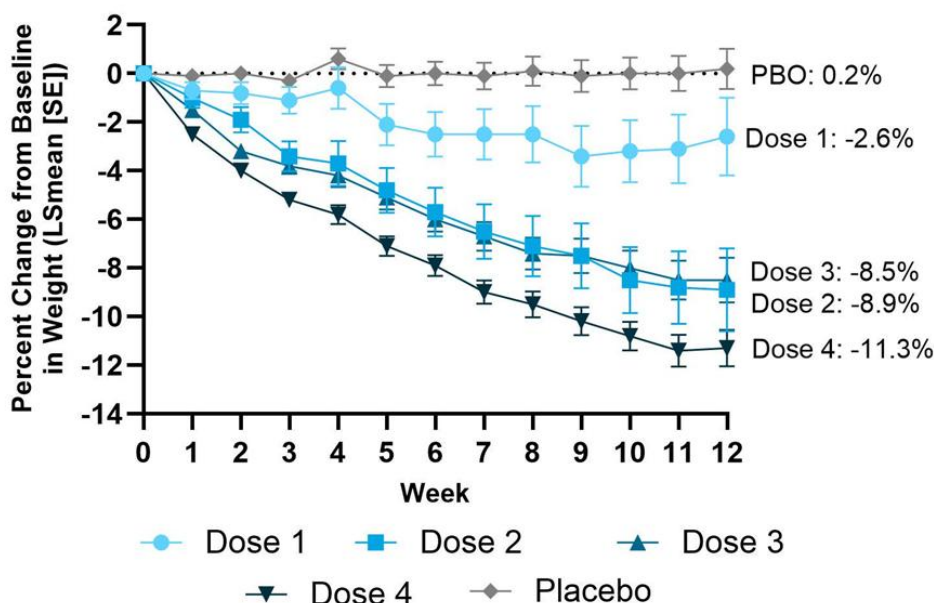
■ Lilly: Eloralintide 减重 Ph1 PoC 研究

Eloralintide (Elora; LY3841136) 是一种强效、长效的每周一次 (QW) 的 Amylin 受体激动剂, 与其他 Amylin 激动剂 (如 Cagrilintide) 不同, 它在临床中设计为具有最小的 Calcitonin (血清降钙素) 活性。

Ph1: 为期 12 周的随机、安慰剂对照、双盲研究，评估每周皮下注射 Elora 在超重或肥胖参与者中的安全性、耐受性、药代动力学（PK）和药效动力学（PD）。共纳入 100 名参与者，平均年龄 44 岁，女性占 29%，BMI 在 27–43 kg/m²，按 5 个多剂量递增队列随机分配至 Elora 或安慰剂组。

有效性: Elora 的平均半衰期为 13.9~15.8 天。第 12 周时，Elora 组的体重最小二乘平均百分比变化为-2.6%至-11.3%（Semaglutide 及 Tirzepatide 剂量爬坡组，第 12 周安慰剂调整后减重幅度约 6%~8%，Metsera 的 MET-097 1.2 mg 固定剂量无爬坡组第 12 周减重-11.3%）。

图2: Eloralintide 12 周减重数据



资料来源：ADA 2025，国信证券经济研究所整理

安全性: Elora 组常见的治疗相关不良事件（TEAE）包括食欲下降（19%）、头痛（12%）、疲劳（11%）和 COVID-19（11%）。胃肠道不良反应较少见：腹泻（10%）、恶心（8%）、呕吐（4%）。大多数 TEAE 为轻度。未发生死亡，1 例（4%）严重不良事件与 Elora 无关。

■ Metsera: MET-233 是具有每月一次给药潜力的 Amylin 类似物

临床前: 在猪中，MET-233 的半衰期为 125 小时，而 Cagrilintide 为 83 小时；MET-233 和 MET-097 在广泛的 pH 范围内均具有良好的溶解性；在大鼠中，MET-233、CagriSema 和 MET-233 联合 MET-097 的 28 天慢性给药均可降低体重，安慰剂调整后减重幅度分别为-17.6%、-14.8%和-31.2%。

Ph1: 研究共招募肥胖/超重且不伴 T2D 受试者 80 名（BMI ~32），接受 MET-233 单剂 0.15~2.4 mg 或每周一次 0.15~1.2 mg 无爬坡连续给药 5 周；

有效性: MET-233 半衰期达到~19 天；受试者体重较基线下降幅度呈剂量依赖，第 36 天，1.2 mg QWx5 组安慰剂调整后体重降幅-8.4%（单个受试者最高降幅达

到-10.4%)，单剂给药组体重降幅维持超过4周；

安全性：MAD队列受试者副反应以胃肠道副反应为主，均为轻度不良反应，且主要集中在给药的第一周，未观察到任何严重不良反应；0.15/3.00 mg组安全性数据与安慰剂组相似。

MET-233单药爬坡QW给药12周+第13周QM剂量暴露的临床研究正在进行中，预计2025H2读出topline数据；Metsera计划推进MET-233联用MET-097的12周给药临床研究，topline数据预计将于2025年底~2026年初读出。

■ Roche/Zealand: Petrelintide 公布 Ph1 16周减重数据

Ph1：研究纳入48名健康超重/肥胖受试者（79%为男性，中位年龄49岁，BMI 29 kg/m²，体重92 kg，腰围102cm），随机以3:1分配至Petrelintide或安慰剂组，分为三组治疗16周。剂量逐渐递增后，目标剂量分别为2.4 mg、4.8 mg和9.0 mg，分别维持12周、8周和6周。所有受试者及Petrelintide组的男女受试者均报告不良事件（AEs）、体重和腰围。合并的安慰剂组仅包括2名女性。

有效性：16周时，三个Petrelintide剂量组平均体重较基线分别-4.8%/-8.6%/-8.3% vs -1.7% pbo，腰围分别-5.0/-7.2/-7.6 cm vs -1.9 cm pbo；女性在三个剂量组中均表现出更显著的治疗反应。

图3: Petrelintide 16周减重数据

	Dose group					
	2. 4 mg (N=12)		4.8 mg (N=11)		9.0 mg (N=10)	
BW reductions	4.8 %		8.6 %		8.3 %	
Mean (min-max)	(2.7-8.4%)		(0.1-14.8%)		(1.3-17.0%)	
WC reductions	5.0 cm		7.2 cm		7.6 cm	
Mean (min-max)	(2-20cm)		(-2-17cm)		(2-18cm)	
	Per sex per dose group					
	2. 4 mg		4.8 mg		9.0 mg	
	Women (N=2)	Men (N=10)	Women (N=3)	Men (N=8)	Women (N=2)	Men (N=8)
BW reduction	7.0%	4.4%	12.6%	7.1%	14.6%	6.8%
Mean (min-max)	(5.6-8.4%)	(2.7-6.8%)	(9.2-14.8%)	(0.1-10.7%)	(12.1-17.0%)	(1.3-10.3%)
WC reduction	12.5 cm	3.5 cm	13 cm	5 cm	14.5 cm	5.9 cm
Mean (min-max)	(5-20 cm)	(2-6 cm)	(8-17 cm)	(-2-11 cm)	(11-18 cm)	(2-9 cm)

BW=body weight; WC=waist circumference

资料来源：ADA 2025，国信证券经济研究所整理

安全性：胃肠道不良事件发生率较低，仅有1例因胃肠不良事件终止治疗，呕吐仅报告于该患者，胃肠道不良事件发生率在性别间无明显差异。

■ 博瑞医药：BGM1812 临床前数据

Amylin受体激动剂（如Petrelintide和Cagrilintide）已显示出在体重管理方面的潜力，BGM1812是一种新型的Amylin类似物，采用人工智能/机器学习（AI/ML）驱动优化设计，旨在增强激动剂活性和制剂特性。本研究评估了BGM1812的药理特性、减重疗效，以及与GLP-1/GIP双重激动剂（BGM0504）在饮食诱导肥胖（DIO）大鼠中的潜在协同作用。

受体激活：采用 cAMP 测定法，测量 Amylin 和 Calcitonin 受体的 EC50 值。BGM1812 在 Amylin 和 Calcitonin 受体上的激动活性分别比 Petrelintide（Roche/Zealand 开发的长效 Amylin 类似物）高~1.8x 和~2.2x（EC50 值）。

药代动力学：在大鼠中进行药代动力学研究，评估皮下注射后的暴露和清除特性。BGM1812 显示出与 Petrelintide 相似的药代动力学特征。

减重疗效：DIO 大鼠接受皮下注射 BGM1812（0.012~0.12 mg/kg，每 3 天一次）28 天，监测体重变化。BGM1812 在 0.012~0.12 mg/kg 剂量范围内表现出剂量依赖性的体重下降；在 0.04 mg/kg 剂量下，BGM1812 引起的体重减少超过 Petrelintide。

联合治疗：分别单独和联合使用 BGM1812（0.4 mg/kg）和 BGM0504（0.15 mg/kg），比较其对体重的影响。BGM1812 与 BGM0504 联合使用，导致更深且更持久的体重下降-28%，相比之下，BGM0504 单独使用为-15%，BGM1812 单独使用为-13%，提示存在协同效应。

制剂研究：评估 BGM1812 制剂在生理 pH（6.5~7.5）下的溶解度和稳定性。BGM1812 在生理 pH 下表现出高溶解度，并保持稳定性，无纤维形成。

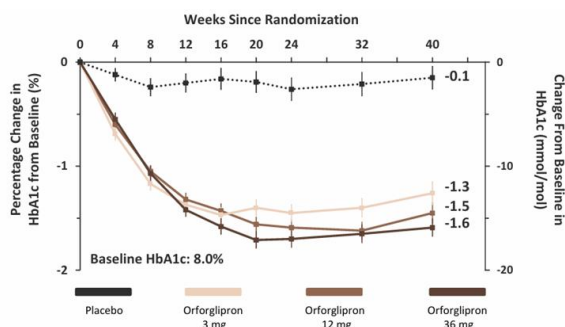
口服小分子 GLP-1

■ Lilly: Orforglipron T2D Ph3 临床研究数据

ACHIEVE-1 是一项为期 40 周的 3 期随机双盲安慰剂对照试验，旨在比较单用 orforglipron 3mg、12mg 和 36mg 与安慰剂单独治疗患有二型糖尿病且仅通过饮食和运动血糖控制不充分的成人的疗效和安全性。该试验以 1:1:1:1 的比例将美国、中国、印度、日本和墨西哥的 559 名参与者随机分组，接受 3mg、12mg 或 36mg 的 orforglipron 或安慰剂。

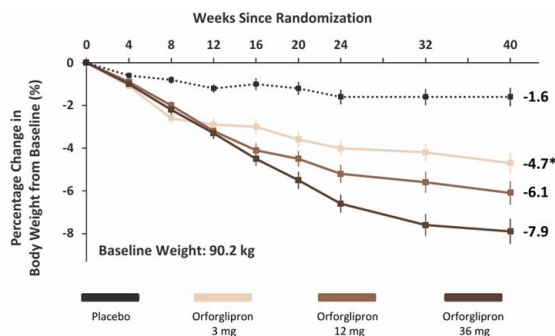
有效性：在第 40 周时，orforglipron 达到主要终点，即相较安慰剂显著降低糖化血红蛋白(A1C)水平，平均从基线的 8.0 个百分点下降了 1.3 至 1.6 个百分点（采用疗效估计量分析）。在关键次要终点方面，超过 65% 的患者在使用最高剂量 orforglipron 后，其 A1C 降至≤6.5 个百分点，低于美国糖尿病协会(ADA)定义的糖尿病诊断阈值；接受最高剂量 orforglipron 治疗的患者平均体重减轻 16.0 磅 (7.9%)，且患者在研究结束时尚未达到体重减轻平台期。

图4：第 40 周 HbA1c 较基线变化



资料来源：ADA 2025，国信证券经济研究所整理

图5：第 40 周平均体重较基线变化



资料来源：ADA 2025，国信证券经济研究所整理

安全性：orforglipron 的整体安全性特征与 GLP-1 类药物的既有安全性一致。最常见的不良事件与胃肠道相关，且大多为轻度至中度。Orforglipron 组(3mg、12mg 和 36mg)的常见不良事件包括：腹泻(19%、21%、26%，VS 安慰剂 9%)、恶心(13%、18%、16%，VS 安慰剂 2%)、消化不良(10%、20%、15%，VS 安慰剂 7%)、便秘(8%、17%、14%，VS 安慰剂 4%)和呕吐(5%、7%、14%，VS 安慰剂 1%)。因不良事件导致的治疗中断的比例分别为 6%(3mg)、4%(12mg)、8%(36mg)，对比安慰剂的 1%。未观察到肝脏安全性信号。

■ 恒瑞医药：口服小分子 GLP-1R 激动剂 HRS-7535 减重/降糖 Ph2 数据

减重 Ph2：研究共纳入 235 名 BMI 为 28~40 kg/m² 且不伴 T2D 的成人受试者，接受每日一次口服 HRS-7535 30/60/120/180 mg 或安慰剂，治疗持续 36 周(26w 治疗+10w 延续期)。

有效性：第 26 周，HRS-7535 30/60/120/180 mg 或安慰剂组受试者体重较基线分别-3.0%/-7.2%/-6.2%/-9.4% vs -2.5% pbo；第 36 周，180 mg 组的体重变化为-9.5% vs -1.4% pbo，降幅≥10%受试者比例 35.4% vs 6.5% pbo。

安全性：HRS-7535 组受试者治疗相关不良反应(TEAEs)发生率为 87.2%~95.8% vs 87.0% pbo；最常见的 TEAEs 为胃肠道反应，包括恶心(16.7%~54.2%)、腹泻(16.7%~21.7%)、呕吐(15.7%~37.5%)，大多数为轻度至中度，且主要发生在剂量递增期间；未观察到肝酶升高的趋势。

降糖 Ph2：研究共纳入 194 名 Metformin 治疗效果不佳的 T2D 患者(平均年龄 52.3 岁，HbA1c 8.5%，BMI 26.7 kg/m²，平均体重 73.4 kg)，接受每日一次口服 HRS-7535 15/30/60/90 mg 或安慰剂，治疗持续 16 周。

有效性：第 16 周，HRS-7535 15/30/60/90 mg 组 HbA1c 变化分别为 -0.94%/-1.34%/-1.57%/-1.39% (ACHIEVE-1 研究中，第 40 周 Orforglipron 3/12/36 mg 组 A1c 较基线 8.0%分别-1.3%/-1.6%/-1.5% vs -0.1% pbo)，显著优于安慰剂组；90 mg 组的体重变化为-2.63% vs -1.30% pbo；HRS-7535 各剂量组在空腹血糖、餐后 2 小时血糖和腰围方面均显示出剂量依赖性的改善；

安全性：HRS-7535 各个剂量组 AE 发生率为 71.8%~84.6% vs 76.8% pbo，最常见的不良事件为胃肠道症状，恶心(7.7%~34.2%)、腹泻(5.1%~15.4%)、呕吐(2.6%~15.8%)等，大多数为轻度至中度；9 名患者(5.8%)出现了低血糖事件，但均为 1 级，未出现 2 级或更严重的低血糖事件。有趋势显示 HRS-7535 组患者的血清淀粉酶和脂肪酶水平有所升高，但未观察到胰腺炎病例。90 mg 组患者的脉搏率较基线增加了 0.21~3.18 次/分钟。

■ 华东医药：HDM1002 Ph1 MAD 数据

入组对象为 18~60 岁的非糖尿病超重或肥胖成人(BMI 24.0~36.0 kg/m²)。受试者按 5:1 比例被随机分配接受不同剂量水平的 HDM1002(50 mg 每日一次、100 mg 每日一次、200 mg 每日一次、100 mg 每日两次或 400 mg 每日一次)或安慰剂，治疗持续 4 周。除 50 mg QD 外，所有组别均进行剂量递增。

有效性：多次给药后，C_{max}(最大血药浓度)呈剂量依赖性增加，AUC(0~24 小

时曲线下面积)增加略高于剂量比例(功效模型分析中 Cmax 的 95%置信区间为 0.772–1.266, AUC 为 1.124–1.587)。在高剂量组中, 28 天治疗期间观察到轻微蓄积。在第 29 天时, 观察到与剂量相关的体重减轻, 在日剂量 ≥ 200 mg 组中, 平均体重减少范围为 4.3 kg 至 6.1 kg, 体重百分比下降为 4.9%至 6.8%;

安全性: 最常见的治疗相关不良事件 (TEAEs) 为胃肠道相关的恶心 (54.0%) 和呕吐 (30.0%), 所有 TEAEs 均为轻至中度。未观察到死亡或严重不良事件。2 名受试者因 TEAE (呕吐和代谢性酸中毒) 中止治疗, 4 名受试者因 TEAE 减量处理。

减脂不减肌

■ Lilly: Bimagrumab 联用 Semaglutide 48 周减重数据

共招募受试者 507 人 (2023 年 6 月完成), BMI ≥ 30 (或 ≥ 27 并伴有至少 1 个肥胖相关疾病, 如高血压), 受试者接受 bima 单药 10/30mg/kg IV Q4W 或联用 Semaglutide 1.0/2.4mg QW, 持续 48 周; 主要终点为第 48 周总体重较基线变化, 次要重点包括第 48/72 周腰围、脂肪量、体脂率等较基线变化。

有效性: 治疗 72 周, Bimagrumab 治疗组减重 10.8%, 但 100%来自于脂肪, 肌肉增加 2.5%; 司美格鲁肽治疗组减重 15.7%, 但只有 71.5%来自于脂肪, 肌肉损失 7.4%; 联合治疗组减重 22.1%, 92.9%来自于脂肪, 肌肉只损失 2.9%; 代谢相关指标, 联合治疗组减去了更多的内脏脂肪, 炎症 biomarker 如 hsCRP 显著降低, 甘油三酯、血压降低幅度更大。Bimagrumab 治疗组 LDL 有所升高, 联合治疗组有微弱升高, 但逐步回到基线。

安全性: 常见副作用包括肌肉痉挛、腹泻、痤疮等, ALT 和脂肪酶早期表现出暂时性的升高。

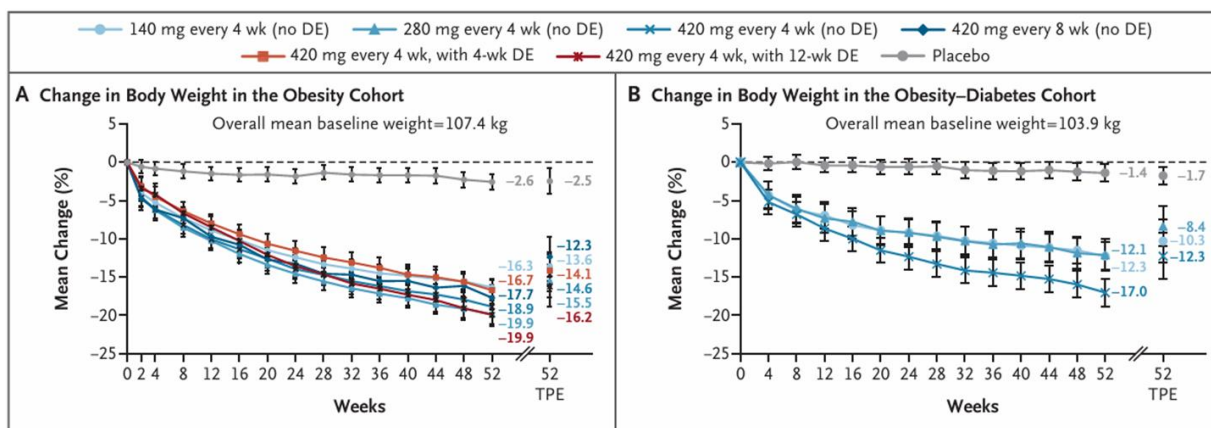
超长效

■ Amgen: MariTide 减重 Ph2 临床研究完整数据

入组肥胖/超重患者 592 例, 其中队列 A (n=465, 其中 63%为女性, 平均体重 107kg, 平均 BMI ~ 38 kg/m²) 患者不伴 T2D, 分为 4 个队列 PBO/140/280/420mg Q4W 或 420mg Q8W SC 给药剂量组, 以及两个剂量递增组 (70mg Q2W x2 随后 420mg Q4W, 以及第 0/4/8 周分别 70/140/280mg Q4W 随后 420mg Q4W)。

有效性: 肥胖/超重且不伴 T2D 队列用药 52 周后, 高剂量组平均体重减轻 $\sim 20\%$, 且没有出现减重平台期; 伴 T2D 患者高剂量组体重平均下降 $\sim 17\%$ (Tirzepatide SURMOUNT-2 研究 10/15mg 剂量组 72 周分别减重-12.8%/-14.7%), 未观察到减重平台期, HbA1c 降低 ~ 2.2 个百分点;

图6: MariTide Ph2 临床肥胖/超重 +/- T2D 患者 52 周减重数据



资料来源: NEJM, 国信证券经济研究所整理

安全性: 最常见的不良事件与胃肠道有关, 包括恶心、呕吐和便秘; 在大约 100 人的剂量递增组中, 总体因不良事件停药率约为 11% (Semaglutide STEP-1 研究及 Tirzepatide SURMOUNT-1 研究停药比例分别为~6%/~7%), 其中因胃肠道副作用而停药的患者比例低于 8% (大部分为轻中度, 且主要发生在首次给药, 剂量爬坡可改善 GI 耐受)。

■ 甘李药业: GZR18 Q2W 降糖数据优于 Semaglutide

Ph2b: 研究共招募 272 名符合条件的成年 T2D 患者 (基线 HbA1c 为 7–11%), 包括初治或已接受口服降糖药稳定治疗的患者, 接受 GZR18 12/18/24 mg SC Q2W、24 mg QW 或 Semaglutide 1 mg QW (对照组), 治疗持续 24 周。

有效性: 第 24 周, GZR18 12/18/24 mg SC Q2W 及 24 mg QW 组 HbA1c 较基线分别-1.87%/-2.28%/-1.94%/-2.32% vs -1.60% Sema (SURPASS-2 研究, 第 40 周 Tirzepatide 5/10/15 mg QW 组 HbA1c 分别 -2.01%/-2.24%/-2.30% vs -1.86% Sema), 其中 GZR18 18 mg Q2W 和 24 mg QW 组相比 Semaglutide 组差异具有统计学显著性;

图7: T2D 患者中 GZR18 对照 Semaglutide 治疗 24 周数据

	Bofanglutide Q2W			Bofanglutide QW	Semaglutide QW
	12 mg (N=55)	18 mg (N=53)	24 mg (N=54)	24 mg (N=52)	1 mg (N=50)
Demographic (FAS), Week 24^a					
Age (years)	50.0 (11.1)	50.3 (9.2)	50.0 (10.6)	52.4 (11.4)	50.5 (10.5)
Male, n (%)	36 (66)	31 (59)	35 (65)	29 (56)	31 (62)
BMI (kg/m ²)	28.38 (4.43)	28.13 (5.08)	28.29 (4.56)	26.27 (3.30)	28.52 (4.80)
Diabetes duration (years)	4.29 (3.67)	3.71 (3.86)	4.04 (4.50)	4.68 (4.48)	4.45 (4.47)
Primary Endpoint (FAS), Week 24^a					
HbA1c (%)					
Baseline	8.56 (1.12)	8.31 (1.02)	8.31 (0.94)	8.28 (1.07)	8.28 (0.93)
CFB at the EOT	-1.87 (-2.11, -1.63)	-2.28 (-2.54, -2.03)	-1.94 (-2.19, -1.69)	-2.32 (-2.57, -2.06)	-1.60 (-1.85, -1.35)
Difference in CFB vs. SEMA	-0.27 (-0.61, -0.08)	-0.68 (-1.04, -0.33)**	-0.34 (-0.70, 0.02)	-0.72 (-1.08, -0.36)**	
Key Secondary Endpoints (FAS), Week 24^a					
HbA1c targets (%)					
<7.0%	72.73	73.58	62.96	75.00	70.00
≤6.5%	58.18	67.92	59.26	69.23	62.00
FPG (mmol/L)					
Baseline	9.90 (2.22)	9.63 (1.99)	9.67 (2.22)	10.02 (2.52)	10.00 (2.71)
CFB at the EOT	-2.31 (-3.00, -1.62)	-2.74 (-3.46, -2.02)	-2.37 (-3.09, -1.66)	-3.87 (-4.60, -3.15)	-2.23 (-2.96, -1.49)
Difference in CFB vs. SEMA	-0.09 (-1.09, 0.92)	-0.52 (-1.56, 0.52)	-0.15 (-1.19, 0.89)	-1.65 (-2.70, -0.60)	
Body weight (kg)					
Baseline	78.37 (16.32)	77.91 (14.63)	78.97 (16.65)	71.29 (13.07)	79.10 (18.36)
CFB at the EOT	-5.18 (-6.35, -4.02)	-5.42 (-6.61, -4.22)	-4.26 (-5.44, -3.07)	-6.54 (-7.74, -5.33)	-3.25 (-4.47, -2.02)
Difference in CFB vs. SEMA	-1.93 (-3.63, -0.24)	-2.17 (-3.88, -0.46)	-1.01 (-2.71, 0.70)	-3.29 (-5.01, -1.57)	
Key Safety Endpoints (SS), Week 24^a					
	N=55	N=53	N=55	N=54	N=54
IP-related AEs	51 (92.7)	48 (90.6)	50 (90.9)	49 (90.7)	39 (72.2)
IP-related SAEs	1 (1.8)	0 (0.0)	1 (1.8)	0 (0.0)	0 (0.0)
Hypoglycemia	0 (0.0)	2 (3.8)	0 (0.0)	1 (1.9)	1 (1.9)
Severe hypoglycemia	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
IP-related gastrointestinal AEs	45 (81.8)	43 (81.1)	48 (87.3)	43 (79.6)	24 (44.4)
Nausea	35 (63.6)	25 (47.2)	37 (67.3)	31 (57.4)	14 (25.9)
Vomiting	26 (47.3)	25 (47.2)	33 (60.0)	26 (48.1)	6 (11.1)
Diarrhea	25 (45.5)	21 (39.6)	25 (45.5)	20 (37.0)	14 (25.9)

资料来源：ADA 2025，国信证券经济研究所整理

安全性：最常见的不良事件为 1~2 级的胃肠道反应，未观察到 3 级或以上不良事件，也未见与 GZR18 相关的严重低血糖。

新股上市跟踪

◆ 近期 A 股/H 股医药板块新股上市情况跟踪

表1: 近期 A 股/H 股医药板块新股上市情况跟踪

证券代码	公司简称	上市进展	公司简介
2609. HK	佰泽医疗	6 月 13 日招股、6 月 13 日-6 月 18 日申购	公司是中国主要从事投资及提供医疗相关服务的肿瘤医疗集团。公司是肿瘤全周期医疗服务领域的服务供应商，筛查、诊断、治疗及康复是公司在肿瘤全周期医疗服务体系中提供的核心服务。公司的价值主张是以人为本，专注于开展肿瘤相关医疗服务，包括但不限于对患者开展肿瘤诊断、多种手段的肿瘤治疗、肿瘤康复及临终关怀等，以及对包括肿瘤患者家属在内的其他潜在健康人群开展的早癌筛查、肿瘤疫苗接种、健康管理服务。
2617. HK	药捷安康-B	6 月 13 日招股、6 月 13 日-6 月 18 日申购	公司是一家以临床需求为导向、处于注册临床阶段的生物制药公司，专注于发现及开发肿瘤、炎症及心脏代谢疾病小分子创新疗法。公司的使命是秉承以原创技术为业务发展驱动力的核心价值观，为全球患者提供创新及差异化的治疗解决方案。凭藉本身全面集成的内部研发系统，公司已建立六款临床阶段候选产品及一种临床前候选产品的管线，公司计划继续扩大公司的管线。进一步借助对转化医学及药物设计的深入研究，公司旨在战略性地开发具有首创性或同类最佳的药品候选物，以满足全球范围内的迫切临床需求。
3880. HK	泰德医药	6 月 20 日招股、6 月 20 日-6 月 25 日申购	公司是全球第三大专注于多肽的 CRDMO，市场份额为 1.5%。公司亦是全球专注于多肽的最全面的 CRDMO 之一，提供从早期发现、临床前研究及临床开发以至商业化生产的全周期服务。全球专注于多肽的 CRDMO 市场的两大参与者占 23.8% 的市场份额，其余市场参与者则较为分散，2023 年第三至六大参与者（包括本公司）分别仅占约 1% 的市场份额。公司主要提供 (i) CRO 服务，即多肽 NCE 发现合成；及 (ii) CDMO 服务，即多肽 CMC 开发以及商业化生产。公司的服务主要专注于向客户提供 API，而非药品。公司已在超过 50 个国家建立稳定的客户关系和服务范围，其中包括中国、美国、日本、欧洲、韩国及澳大利亚等主要市场。公司为客户提供符合全球主要市场监管规定的多肽类药物开发、生产、CMC 申报支持服务。

资料来源：中国证监会，港交所，国信证券经济研究所整理

本周行情回顾

本周全部 A 股下跌 0.67%（总市值加权平均），沪深 300 下跌 0.45%，中小板指下跌 0.43%，创业板指下跌 1.66%，生物医药板块整体下跌 4.35%，生物医药板块表现弱于整体市场。分子板块来看，化学制药下跌 5.48%，生物制品下跌 3.94%，医疗服务下跌 4.92%，医疗器械下跌 3.24%，医药商业下跌 4.42%，中药下跌 2.93%。

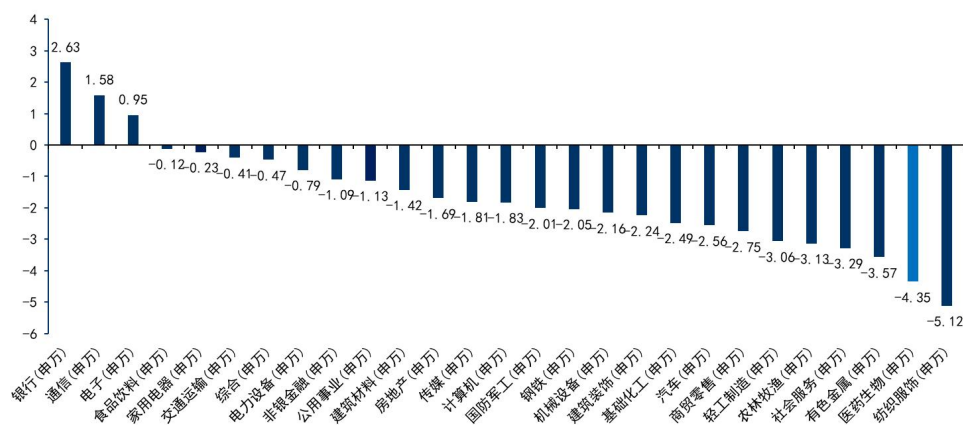
个股方面，涨幅居前的是*ST 贤丰（21.87%）、昂利康（21.21%）、悦康药业（19.34%）、创新医疗（18.96%）、济民健康（12.36%）、爱朋医疗（11.42%）、ST 百灵（10.55%）、易明医药（10.02%）、圣达生物（9.26%）、启迪药业（8.86%）。

跌幅居前的是澳洋健康（-26.33%）、康惠制药（-20.92%）、浩欧博（-19.37%）、百洋医药（-19.01%）、华纳药厂（-16.97%）、科兴制药（-16.85%）、千红制药（-15.64%）、诺诚健华-U（-15.34%）、奥赛康（-15.08%）、一品红（-14.78%）。

本周恒生指数下跌 1.52%，港股医疗保健板块下跌 7.78%，板块相对表现弱于恒生指数。分子板块来看，制药板块下跌 7.06%，生物科技下跌 6.50%，医疗保健设备下跌 3.49%，医疗服务下跌 3.22%。

市场表现居前的是（仅统计市值 50 亿港币以上）MIRXES-B（19.07%）、亚盛医药-B（15.88%）、先健科技（7.37%）、微创脑科学（6.69%）、欧康维视生物-B（6.60%）；跌幅居前的是健康之路（-60.58%）、君实生物（-20.47%）、再鼎医药（-16.44%）、康宁杰瑞制药-B（-15.13%）。

图8：申万一级行业一周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

表2: 本周 A 股涨跌幅前十的个股情况

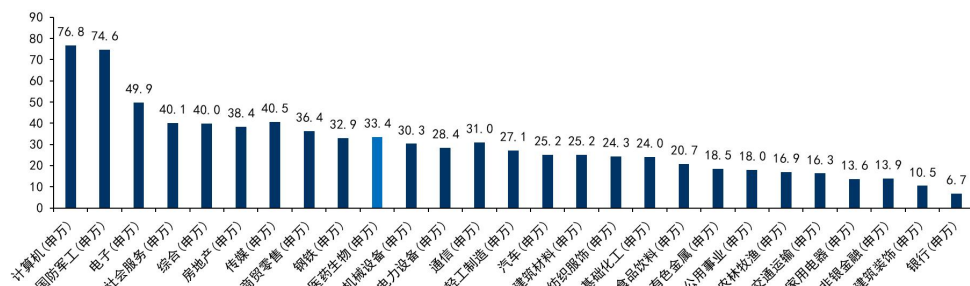
本周涨幅前十		本周跌幅前十	
股票简称	涨幅	股票简称	跌幅
*ST 贤丰	21.87%	澳洋健康	-26.33%
昂利康	21.21%	康惠制药	-20.92%
悦康药业	19.34%	浩欧博	-19.37%
创新医疗	18.96%	百洋医药	-19.01%
济民健康	12.36%	华纳药厂	-16.97%
爱朋医疗	11.42%	科兴制药	-16.85%
ST 百灵	10.55%	千红制药	-15.64%
易明医药	10.02%	诺诚健华-U	-15.34%
圣达生物	9.26%	奥赛康	-15.08%
启迪药业	8.86%	一品红	-14.78%

资料来源: Wind, 国信证券经济研究所整理 注: 本表仅做列示, 不做推荐

板块估值情况

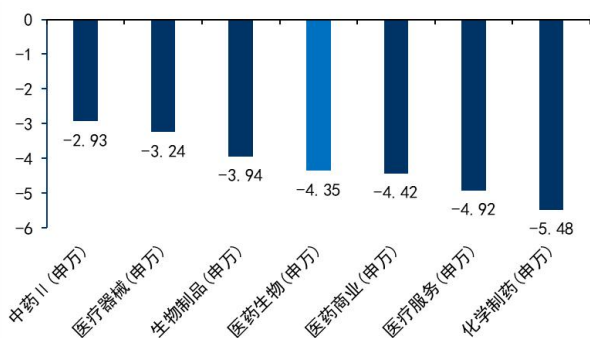
医药生物市盈率（TTM）33.39x，全部A股（申万A股指数）市盈率18.35x。分板块来看，化学制药41.05x，生物制品39.73x，医疗服务29.56x，医疗器械33.18x，医药商业19.33x，中药26.88x。

图9：申万一级行业市盈率情况（TTM）



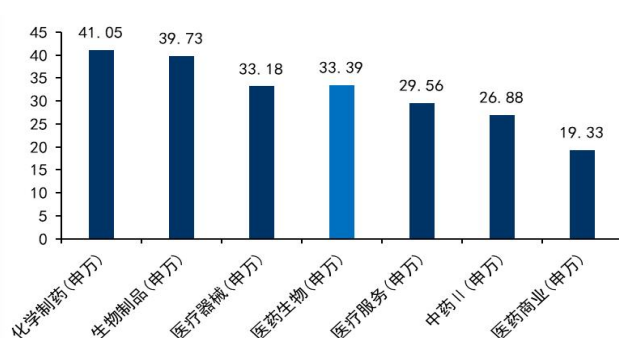
资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图10：医药行业子板块一周涨跌幅（%）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

图11：医药行业子板块市盈率情况（TTM）



资料来源：Wind，国信证券经济研究所整理

推荐标的

迈瑞医疗：公司作为国产医疗器械龙头，研发和销售实力强劲，国际化布局成果显著。公司受益于国内医疗新基建和产品迭代升级，并在海外加快高端客户拓展。微创外科、心血管等种子业务高速放量，“三瑞”数智化方案引领转型升级。

药明康德：公司是行业中极少数在新药研发全产业链均具备服务能力的开放式新药研发服务平台，有望全面受益于全球新药研发外包服务市场的快速发展。公司“一体化、端到端”的新药研发服务平台，无论是在服务的技术深度还是覆盖广度方面都能满足客户提出的多元化需求。

新产业：公司为化学发光免疫分析领域的龙头，拥有技术、生产和销售等方面的多重优势，坚实庞大的装机基础未来将持续带动试剂销售，促进进口替代，同时国际化和平台化布局将开启新成长曲线。

惠泰医疗：公司专注电生理和介入类医疗器械研发、生产及销售，在相关领域品种齐全、规模领先。已上市产品涵盖电生理、冠脉通路、外周血管介入及非血管介入医疗器械。2024 年迈瑞医疗完成对公司的控制权收购，成为实际控制人，凭借迈瑞在医疗器械领域的行业地位及丰富经验，公司有望实现海内外市场拓展及产品研发等方面的全方位赋能，巩固在心血管领域的领先地位。

开立医疗：开立医疗是国内“超声+软镜”行业领军企业，持续丰富业务矩阵，公司超声业务已经历 20 多年发展，建立了较为完善的营销网络渠道，超声行业也逐步进入成熟期。作为国产软镜后起之秀，开立在国内市场已跻身市占率第三。同时持续布局微创外科和心血管介入，新业务成长可期。

澳华内镜：公司为国产软镜设备龙头，软镜市场国产化率提升空间巨大，公司旗舰产品 AQ-300 于 2022 年底上市，性能媲美进口产品，目前市场推广进展顺利，有望带动收入高增长和盈利能力提升。

艾德生物：公司是肿瘤精准诊断领域的龙头企业，产品线布局领先，构建了从靶向治疗到免疫治疗的全方位伴随诊断产品体系，在院内渠道具备强大的销售壁垒；此外，公司产品顺利出海，中长期发展空间广阔。

爱博医疗：公司是国内首家自主开发高端屈光性人工晶状体的厂家，且在中国境内第 2 家取得角膜塑形镜注册证，隐形眼镜正处于快速放量阶段。公司拥有丰富在研管线，未来平台化和国际化发展潜力大。

金域医学：公司基于高强度的自主研发和产学研一体化，每年推出数百项创新项目，高端技术平台的不断完善和“医检 4.0”数字化转型战略落地将驱动公司盈利能力稳健提升。

康方生物(9926.HK)：公司为专注创新的双抗龙头，在研管线丰富，双抗、ADC、单抗等不同分子形态已形成梯队。依沃西持续验证 FIC & BIC 潜力，公司与 Summit 合作持续推进全球的临床。卡度尼利与依沃西已经成功实现了国内商业化，有望成为重磅品种。

科伦博泰生物-B(6990.HK)：公司 ADC 产品早期临床数据优秀，研发进度在全球范围内较为领先，且已经与默沙东达成了深度的合作，有利于产品实现在全球的商业化潜力。公司未来 2~3 年的营收主要来源于默沙东的首付款和里程碑付款，产品销售将在 2025 年后开始放量。

和黄医药(0013.HK)：公司是一家处于商业化阶段的创新型生物医药公司，专注

于发现、开发及商业化治疗癌症及免疫性疾病的靶向疗法及免疫疗法。呋喹替尼 2023 年底在美国获批上市后迅速放量，赛沃替尼也有望向 FDA 递交上市申请，索乐匹尼布临床数据优秀，预计将于 2025 年获批上市。

康诺亚-B(2162.HK)：公司的司普奇拜单抗是首个获批上市的国产 IL4R 单抗，季节性过敏性鼻炎适应症是司普奇拜单抗获批的第三个适应症，此前，成人中重度特应性皮炎适应症和慢性鼻窦炎伴鼻息肉适应症分别于 2024 年 9 月和 2024 年 12 月获批上市，三个适应症均有可能通过 2025 年的国谈进入医保。

三生制药(01530.HK)：公司是一家集研发、生产和销售为一体的生物制药领军企业，在肾科、皮肤科、自身免疫科、肿瘤科的药物有多年的研发、销售经验。

爱康医疗(1789.HK)：公司是中国第一家将 3D 打印技术商业化的人工关节领域龙头公司，公司产品线齐全，借助集采提升市场份额，加速进口替代，巩固龙头地位。骨生物材料和数字化骨科将成为新增长点。

风险提示

研发失败风险；商业化不及预期风险；地缘政治风险；政策超预期风险。

附表：重点覆盖公司盈利预测及估值

代码	公司简称	子行业	总市值 (亿元)	归母净利润(亿元)				PE				ROE		PEG	投资 评级
				24A	25E	26E	27E	24A	25E	26E	27E	24A	25E		
300760.SZ	迈瑞医疗	300760.SZ	2,755	116.7	124.1	141.0	161.9	23.6	22.2	19.5	17.0	32.5%	1.9	1.9	优于大市
300832.SZ	新产业	300832.SZ	456	18.3	20.4	24.3	28.8	24.9	22.4	18.8	15.8	21.3%	1.4	1.4	优于大市
688212.SH	澳华内镜	688212.SH	62	0.2	0.5	1.0	1.2	295.1	114.8	63.3	50.0	1.5%	1.4	1.4	优于大市
688161.SH	威高骨科	688161.SH	102	2.2	2.5	3.1	3.8	45.4	40.0	32.5	26.9	5.7%	2.1	2.1	优于大市
688271.SH	联影医疗	688271.SH	1,059	12.6	17.0	20.8	23.3	83.9	62.2	51.0	45.5	6.3%	2.7	2.7	优于大市
688050.SH	爱博医疗	688050.SH	131	3.9	4.7	5.8	7.2	33.7	27.9	22.6	18.2	16.1%	1.2	1.2	优于大市
301363.SZ	美好医疗	301363.SZ	95	3.6	4.6	5.7	6.9	26.0	20.4	16.7	13.7	10.5%	0.9	0.9	优于大市
688236.SH	春立医疗	688236.SH	56	1.2	2.2	2.7	3.3	44.5	25.0	20.4	16.8	4.4%	0.7	0.7	优于大市
300049.SZ	福瑞股份	300049.SZ	81	1.1	2.1	2.8	3.6	71.3	39.0	28.9	22.4	6.5%	0.8	0.8	优于大市
300463.SZ	迈克生物	300463.SZ	70	1.3	2.7	3.5	4.2	55.4	25.7	19.8	16.6	2.0%	0.5	0.5	优于大市
300685.SZ	艾德生物	300685.SZ	82	2.5	3.2	3.8	4.5	32.1	25.8	21.4	18.2	13.8%	1.2	1.2	优于大市
688358.SH	祥生医疗	688358.SH	31	1.4	1.7	2.0	2.3	21.8	18.0	15.6	13.6	9.9%	1.1	1.1	优于大市
688389.SH	普门科技	688389.SH	53	3.5	5.1	6.2	-	15.4	10.5	8.5	-	16.8%	0.3	0.3	优于大市
688029.SH	南微医学	688029.SH	121	5.5	6.9	8.0	8.9	21.9	17.6	15.1	13.7	14.5%	1.0	1.0	优于大市
603301.SH	振德医疗	603301.SH	55	3.9	3.9	5.0	5.7	14.4	14.2	11.2	9.7	6.8%	1.0	1.0	优于大市
688626.SH	翔宇医疗	688626.SH	57	1.0	1.4	1.8	2.2	55.2	40.3	32.3	26.3	5.0%	1.4	1.4	优于大市
605369.SH	拱东医疗	605369.SH	41	1.7	1.6	1.9	2.1	23.7	25.3	21.5	19.0	10.1%	3.3	3.3	优于大市
300633.SZ	开立医疗	300633.SZ	129	1.4	3.1	4.0	4.8	90.8	41.3	32.6	26.8	4.6%	0.8	0.8	优于大市
688575.SH	亚辉龙	688575.SH	83	3.0	5.1	6.7	-	27.4	16.1	12.4	-	10.9%	0.3	0.3	优于大市
688617.SH	惠泰医疗	688617.SH	387	6.7	8.8	11.3	14.7	57.5	44.2	34.1	26.3	26.8%	1.5	1.5	优于大市
002653.SZ	海思科	002653.SZ	459	4.0	5.5	6.9	8.7	116.1	83.9	66.2	52.9	9.4%	2.8	2.8	优于大市
688062.SH	迈威生物-U	688062.SH	97	(10.4)	(5.2)	(1.3)	-	(9.3)	(18.9)	(77.3)	-	-66.5%	0.3	0.3	优于大市
300601.SZ	康泰生物	300601.SZ	161	2.0	8.1	10.0	-	79.9	20.0	16.2	-	2.1%	0.2	0.2	优于大市
688687.SH	凯因科技	688687.SH	44	1.4	2.0	2.6	-	31.0	22.1	16.9	-	7.7%	0.6	0.6	优于大市
688319.SH	欧林生物	688319.SH	64	0.2	0.7	1.3	-	309.4	98.8	48.3	-	2.2%	0.6	0.6	优于大市
688443.SH	智翔金泰-U	688443.SH	102	(8.0)	(6.7)	(4.4)	(0.5)	(12.7)	(15.2)	(23.1)	(216.1)	-37.5%	0.2	0.2	优于大市
688278.SH	特宝生物	688278.SH	279	8.3	10.7	15.4	21.7	33.7	26.1	18.1	12.9	32.4%	0.7	0.7	优于大市
000999.SZ	华润三九	000999.SZ	520	33.7	37.4	40.8	48.6	15.4	13.9	12.7	10.7	16.9%	1.1	1.1	优于大市
600557.SH	康缘药业	600557.SH	83	3.9	6.1	6.8	-	21.3	13.7	12.3	-	8.7%	0.4	0.4	优于大市
600129.SH	太极集团	600129.SH	117	0.3	13.0	15.6	-	440.5	9.0	7.5	-	0.8%	0.0	0.0	优于大市
688046.SH	药康生物	688046.SH	49	1.1	1.3	1.7	1.9	44.9	37.4	29.7	26.3	5.1%	1.9	1.9	优于大市
301080.SZ	百普赛斯	301080.SZ	63	1.2	1.6	2.3	2.8	51.3	40.4	28.2	22.5	4.7%	1.3	1.3	优于大市
688293.SH	奥浦迈	688293.SH	43	0.2	0.8	1.1	1.5	205.0	55.3	38.5	28.2	1.0%	0.6	0.6	优于大市
603259.SH	药明康德	603259.SH	1,893	93.5	111.6	127.3	145.1	20.2	17.0	14.9	13.1	16.1%	1.1	1.1	优于大市
000739.SZ	普洛药业	000739.SZ	163	10.3	11.2	12.6	14.0	15.8	14.5	12.9	11.6	15.3%	1.4	1.4	优于大市
603127.SH	昭衍新药	603127.SH	134	0.7	3.3	3.8	4.1	180.5	40.5	35.1	32.4	0.9%	0.5	0.5	优于大市
301096.SZ	百诚医药	301096.SZ	48	(0.5)	0.5	0.9	1.2	(90.4)	90.0	55.5	41.1	-2.0%	-0.4	0.5	优于大市
688076.SH	诺泰生物	688076.SH	119	4.0	5.8	7.9	11.0	29.5	20.5	15.0	10.8	15.2%	0.5	0.5	优于大市
688222.SH	成都先导	688222.SH	62	0.5	0.6	0.8	1.0	120.0	97.8	79.0	63.5	3.7%	4.1	4.1	优于大市
603882.SH	金域医学	603882.SH	125	(3.8)	6.9	8.5	-	(32.7)	18.1	14.8	-	-5.2%	-	-	优于大市
300015.SZ	爱尔眼科	300015.SZ	1,106	35.6	41.4	48.8	57.6	31.1	26.7	22.7	19.2	17.2%	1.5	1.5	优于大市
1066.HK	威高股份	1066.HK	250	20.7	23.0	25.3	27.7	12.1	10.9	9.9	9.0	8.7%	1.6	1.6	优于大市
1789.HK	爱康医疗	1789.HK	61	2.7	3.3	4.0	4.8	22.2	18.2	15.1	12.6	10.4%	0.9	0.9	优于大市
2005.HK	石四药集团	2005.HK	73	9.8	9.5	9.9	10.8	7.4	7.7	7.4	6.8	14.7%	2.5	2.5	优于大市
0512.HK	远大医药	0512.HK	274	22.9	20.3	22.5	25.5	12.0	13.5	12.2	10.7	15.0%	3.6	3.6	优于大市
0013.HK	和黄医药	0013.HK	188	2.7	24.9	8.5	11.8	69.4	7.6	22.1	16.0	5.0%	0.1	0.1	优于大市
2162.HK	康诺亚-B	2162.HK	122	(5.2)	(8.0)	(5.8)	0.5	(23.6)	(15.2)	(20.9)	253.5	-20.8%	0.1	0.1	优于大市
9926.HK	康方生物	9926.HK	748	(5.1)	0.3	7.3	17.9	(145.5)	2581.0	102.5	41.7	-7.6%	-10.3	0.4	优于大市
1530.HK	三生制药	1530.HK	456	20.9	23.9	27.1	30.7	21.8	19.1	16.8	14.9	13.5%	1.4	1.4	优于大市
6990.HK	科伦博泰生物-B	6990.HK	686	(2.7)	(7.2)	(3.0)	4.8	(257.2)	(95.2)	(227.2)	144.5	-8.1%	0.4	0.4	优于大市
2480.HK	绿竹生物-B	2480.HK	46	(1.7)	(1.5)	(1.3)	1.2	(27.4)	(31.5)	(36.3)	39.7	-19.7%	0.2	0.2	优于大市

2268. HK	药明合联	2268. HK	440	10.7	14.0	19.2	26.0	41.1	31.5	23.0	16.9	16.1%	0.9	优于大市
2273. HK	固生堂	2273. HK	72	3.1	3.8	4.8	6.1	23.4	18.9	14.9	11.8	12.9%	0.7	优于大市
2666. HK	环球医疗	2666. HK	93	20.3	21.2	22.0	22.9	4.6	4.4	4.2	4.1	11.8%	1.1	优于大市
2522. HK	一脉阳光	2522. HK	42	(0.5)	0.5	0.8	1.1	(91.6)	85.8	51.9	37.2	-3.2%	-0.4	优于大市

数据来源：Wind，国信证券经济研究所整理、预测

注：总市值以 2025/6/20 股价计算

免责声明

分析师声明

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 到 12 个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的 6 到 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A 股市场以沪深 300 指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票 投资评级	优于大市	股价表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	股价表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	股价表现弱于市场代表性指数 10%以上
		无评级	股价与市场代表性指数相比无明确观点
	行业 投资评级	优于大市	行业指数表现优于市场代表性指数 10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数 $\pm 10\%$ 之间
		弱于大市	行业指数表现弱于市场代表性指数 10%以上

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中所意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 36 层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 12 层

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街 6 号国信证券 9 层

邮编：100032